EBOOK PANDUAN

Panduan Kredensial & RKK Staf Medis Rumah Sakit Sesuai Permenkes 6/2026

Susun RKK, white paper kompetensi, dan form evaluasi klinis staf medis RS sesuai Permenkes 6/2026 — tanpa bongkar ulang dari nol.



"Belajar. Praktik. Naik Level."

Diterbitkan oleh **Naik Level Id**
Panduan belajar praktis & aplikatif

B A B 1

Memahami Perubahan Kredensial Staf Medis di Permenkes 6/2026

Perubahan regulasi kredensial staf medis melalui Permenkes 6/2026 bukan sekadar revisi administratif. Ini adalah perombakan menyeluruh yang mengharuskan Komite Medik dan tim kredensial RS memandang ulang seluruh siklus kredensial—dari penetapan Rincian Kewenangan Klinis (RKK), penyusunan white paper kompetensi, hingga evaluasi kinerja klinis berkala. Banyak RS yang selama ini nyaman dengan format lama mendadak harus bergerak cepat, karena dokumen yang tidak sesuai standar baru berpotensi menggugurkan penilaian akreditasi.

Apa yang sebenarnya berubah? Setidaknya ada empat pergeseran besar yang wajib Anda pahami sebelum menyentuh dokumen apa pun.

Pertama, struktur RKK tidak lagi sekadar daftar tindakan medis. Permenkes 6/2026 menuntut setiap kewenangan klinis tertaut langsung ke bukti kompetensi—baik dari pendidikan formal, pelatihan bersertifikat, maupun pengalaman klinis terdokumentasi. Artinya, RKK sekarang harus lebih granular dan terverifikasi, bukan salinan template generik yang sama untuk semua dokter spesialis.

Kedua, white paper kompetensi menjadi dokumen wajib untuk kompetensi tertentu yang dianggap berisiko tinggi atau memerlukan justifikasi khusus. Sebelumnya white paper hanya pelengkap; sekarang menjadi dasar pemberian kewenangan klinis. Komite Medik harus bisa memilah kompetensi mana yang memerlukan white paper terpisah untuk setiap spesialisasi, dan itu menuntut

pemahaman klinis yang mendalam.

Ketiga, evaluasi kinerja klinis staf medis harus terdokumentasi secara konsisten antar periode. Tidak bisa lagi form evaluasi berubah-ubah formatnya setiap tahun atau hanya diisi saat ada masalah. Permenkes 6/2026 mensyaratkan format standar yang dapat ditelusur, lengkap dengan indikator kinerja klinis yang terukur.

Keempat, siklus rekredensial 3 tahunan ditegaskan dengan sistem pengingat dan checklist yang wajib dijalankan. Keterlambatan rekredensial tidak lagi dianggap sebagai masalah administratif kecil, melainkan indikasi lemahnya tata kelola klinis.

Dampaknya ke tugas Komite Medik sangat nyata: Anda tidak bisa lagi mengandalkan dokumen lawas atau copy-paste dari tahun sebelumnya. Semua harus disusun ulang, divalidasi, dan disimpan dalam format yang siap telusur. Direksi RS akan meminta bukti tertulis bahwa kewenangan klinis setiap dokter sudah diverifikasi—bukan sekadar daftar nama di atas kertas.

Untuk itu, langkah pertama bukan langsung membuat template, tetapi memahami peta perubahannya. Lakukan tiga langkah praktis berikut agar tim kredensial tidak bekerja sporadis.

1. **Inventarisir seluruh dokumen kredensial existing.** Kumpulkan semua RKK, white paper, dan form evaluasi kinerja klinis yang pernah dibuat dalam 2–3 tahun terakhir. Jangan nilai dulu—kumpulkan saja.
2. **Petakan kesenjangan terhadap struktur Permenkes 6/2026.** Buat tabel sederhana dengan kolom: nama dokumen, struktur lama, struktur baru yang diminta, dan status (sesuai/perlu revisi/hilang total). Libatkan minimal satu orang dari Komite Medik yang paham klinis dan satu orang administrasi yang teliti.

3. **Tetapkan prioritas berdasarkan risiko.** Dokumen RKK untuk spesialisasi dengan volume tindakan tinggi dan risiko tinggi (misalnya bedah, anestesi, intervensi jantung) harus didahulukan. Jangan menunda karena tenggat implementasi semakin dekat.

> ⚠️ **Penting: Tenggat implementasi Permenkes 6/2026 bukan waktu yang bisa dinegosiasi. Jika RS Anda masih memakai format lama saat survei akreditasi berikutnya, temuan bisa berujung pada rekomendasi perbaikan besar atau bahkan pembekuan kewenangan klinis. Mulailah sekarang, bukan setelah ada teguran.**

Setelah peta kesenjangan selesai, barulah tim bisa menyusun template RKK per spesialisasi, membuat panduan white paper, dan menstandarkan form evaluasi kinerja. Bab-bab selanjutnya akan memandu Anda langkah demi langkah untuk setiap dokumen tersebut.

> ✅ **Checklist: Sebelum lanjut ke bab berikutnya, pastikan Anda sudah bisa menjawab: - Apakah semua RKK lama sudah dikumpulkan dan diberi label? - Apakah sudah ada daftar spesialisasi yang membutuhkan white paper terpisah? - Apakah form evaluasi kinerja klinis yang dipakai saat ini konsisten antar periode? - Apakah ada sistem pengingat rekredensial 3 tahunan yang berjalan, atau masih mengandalkan ingatan staf?**

INTI BAB: Perubahan utama Permenkes 6/2026 memaksa Komite Medik menyusun ulang RKK, white paper kompetensi, dan evaluasi kinerja klinis dengan bukti telusur yang kuat. Langkah awal yang benar adalah memetakan kesenjangan dokumen existing terhadap struktur baru, bukan langsung membuat template.

B A B 2

Struktur Dokumen Kredensial yang Wajib Dimiliki RS

Masalah paling umum yang saya temui di lapangan: Komite Medik paham bahwa dokumen kredensial harus dirombak, tapi bingung mulai dari mana karena tidak ada peta dokumen yang jelas. Akibatnya, tiap bagian membuat format sendiri-sendiri, dan begitu surveyor akreditasi datang, dokumennya amburadul.

Padahal, Permenkes 6/2026 sebenarnya sudah memberikan kerangka yang cukup runut. Tugas kita hanya menyusun dokumen-dokumen itu secara konsisten dan saling terkait. Di bab ini, kita petakan dulu struktur dokumen wajibnya, supaya kamu tidak lagi bekerja secara reaktif.

Tujuh Dokumen Inti yang Harus Ada

Berdasarkan Permenkes 6/2026 dan standar akreditasi terbaru, setiap staf medis yang memiliki kewenangan klinis di rumah sakit harus punya tujuh jenis dokumen ini dalam berkas kredensialnya:

1. **RKK (Rincian Kewenangan Klinis)** – Dokumen inti yang merinci tindakan medis apa saja yang boleh dilakukan dokter tersebut, disusun per spesialisasi dengan format baru yang memuat level kompetensi dan syarat pendukung.
2. **White Paper Kompetensi Klinis** – Dokumen pendukung untuk kewenangan tertentu yang tidak umum, berisi bukti pelatihan, pengalaman, atau supervisi yang membenarkan dokter tersebut layak diberi kewenangan.

3. **Bukti Rapat Kredensial** – Notulen, daftar hadir, dan surat keputusan rapat Komite Medik yang menunjukkan proses pengambilan keputusan kewenangan klinis.
4. **Form Evaluasi Kinerja Klinis** – Instrumen penilaian berkala (misalnya tiap 6 bulan atau 1 tahun) untuk menilai apakah dokter masih kompeten menjalankan kewenangannya.
5. **Dokumen Rekredensial 3 Tahunan** – Berkas hasil peninjauan ulang kewenangan klinis setiap 3 tahun, termasuk bukti pendidikan berkelanjutan (CPD), audit medis, dan rekomendasi Komite Medik.
6. **SK Kewenangan Klinis dari Direktur RS** – Surat keputusan formal yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan klinis, harus diperbarui setiap kali ada perubahan RKK.
7. **Registrasi & Database Kredensial** – Catatan induk yang memuat status kredensial semua staf medis, tanggal jatuh tempo rekredensial, dan riwayat perubahan kewenangan.

> ✅ **Checklist: Pastikan untuk setiap dokter tersedia berkas berikut dalam map individu (fisik atau digital): - [ ] RKK terbaru sesuai struktur Permenkes 6/2026 - [ ] White paper untuk kompetensi khusus (jika ada) - [ ] Notulen rapat kredensial saat kewenangan diberikan - [ ] Form evaluasi kinerja klinis periode terakhir - [ ] Bukti rekredensial 3 tahunan terakhir - [ ] SK Direktur tentang kewenangan klinis yang masih berlaku - [ ] Salinan STR dan SIP yang masih aktif - [ ] Sertifikat pelatihan pendukung kompetensi**

Langkah Praktik: Memetakan Dokumen Lama vs Baru

Jangan langsung panik dan mencoba membuat semua dokumen dari nol dalam semalam. Ikuti lima langkah ini supaya pekerjaanmu terstruktur dan tidak ada yang terlewat.

1. **Bentuk tim kecil (2–3 orang) dari Komite Medik** khusus untuk mengurus pemetaan dokumen. Jangan libatkan terlalu banyak orang karena justru akan memperlambat keputusan.
2. **Unduh atau siapkan template RKK terbaru** yang sudah mengikuti struktur Permenkes 6/2026. Kalau belum punya, lihat contoh dan template lengkap di Bab 5 buku ini.
3. **Inventarisasi semua dokumen kredensial lama** yang dimiliki RS. Buat tabel sederhana berisi nama dokter, spesialisasi, tanggal rekredensial terakhir, dan status dokumen (lengkap/kurang/format lama).
4. **Tandai gap-nya**: mana dokumen yang masih bisa dipakai dengan revisi minor, mana yang harus dirombak total, dan mana yang belum ada sama sekali. Gunakan checklist di atas sebagai acuan.
5. **Prioritaskan staf medis yang jatuh tempo rekredensialnya dalam 6 bulan ke depan.** Susun jadwal penyusunan ulang dokumen untuk kelompok ini lebih dulu, baru sisanya menyusul.

> ⚠️ **Penting: Jangan pernah menganggap remeh bukti rapat kredensial. Surveyor akreditasi sering kali menilai proses kredensial dari notulen rapat, bukan hanya dari keberadaan RKK. Pastikan setiap pemberian atau perubahan kewenangan klinis tercatat dalam notulen dengan jelas: siapa yang dibahas, apa keputusannya, dan apa dasar pertimbangannya.**

Setelah peta dokumen selesai dan gap-nya teridentifikasi, kamu akan jauh

lebih tenang karena tahu persis apa yang harus dikerjakan. Di bab-bab berikutnya, kita akan bedah satu per satu cara menyusun RKK, white paper, dan form evaluasi kinerja klinis sesuai template siap pakai.

INTI BAB: Struktur dokumen kredensial wajib terdiri dari tujuh komponen utama: RKK, white paper, bukti rapat, form evaluasi kinerja, dokumen rekredensial 3 tahunan, SK Direktur, dan database registrasi. Mulailah dengan memetakan dokumen lama vs baru menggunakan checklist, lalu prioritaskan staf medis yang masa rekredensialnya paling dekat agar implementasi Permenkes 6/2026 berjalan efektif tanpa kekacauan.

B A B 3

Menyusun Rincian Kewenangan Klinis (RKK) per Spesialisasi

RKK bukan sekadar daftar tindakan medis yang boleh dilakukan dokter. Di Permenkes 6/2026, RKK menjadi **kontrak klinis tertulis** antara staf medis, Komite Medik, dan Direksi RS. Isinya: kompetensi apa saja yang boleh dikerjakan, dalam kondisi bagaimana, dengan supervisi atau mandiri, serta bukti pendukungnya.

Masalah paling sering muncul: tim kredensial menyalin format RKK lama yang hanya berisi tabel nama tindakan tanpa level kewenangan. Akibatnya, saat rekredensial atau survey akreditasi, tidak jelas apakah dokter tersebut sudah layak melakukan tindakan tertentu secara mandiri atau masih perlu pendampingan.

Berikut langkah praktis menyusun RKK per spesialisasi yang sesuai struktur Permenkes 6/2026.

Langkah 1: Petakan kategori staf medis

Buat tiga kelompok besar: - **Dokter Umum** – layanan primer, emergensi dasar, rawat inap non-spesialistik. - **Dokter Spesialis** – sesuai bidangnya (penyakit dalam, bedah, anak, obgyn, dll). - **Dokter Sub-spesialis** – konsultan atau subspesialis yang memiliki kewenangan lanjutan.

Setiap kategori punya kerangka RKK berbeda, tapi prinsipnya sama: **tindakan klinis inti** dan **tindakan klinis tambahan/pengembangan**.

Langkah 2: Susun daftar kewenangan klinis dengan 4

level

Untuk setiap tindakan, cantumkan level kewenangan: 1. **Mandiri** – dokter dapat melakukan tanpa supervisi. 2. **Dengan supervisi langsung** – supervisor hadir di ruangan. 3. **Dengan supervisi tidak langsung** – supervisor dapat dihubungi dan datang jika diperlukan. 4. **Tidak diberikan kewenangan** – tindakan di luar kompetensi.

Contoh isian untuk **Dokter Umum**:

Tindakan Klinis	Level	Syarat/Ketentuan
Pemasangan infus	Mandiri	Sesuai standar prosedur
Penjahitan luka sederhana	Mandiri	Luka < 5 cm, tanpa komplikasi
Interpretasi EKG dasar	Dengan supervisi tidak langsung	Harus konsul ke spesialis jantung jika abnormal
Tindakan bedah minor	Tidak diberikan	Dirujuk ke spesialis bedah

Untuk **Dokter Spesialis Penyakit Dalam**:

Tindakan Klinis	Level	Syarat/Ketentuan
Pemasangan CVC (Central Venous Catheter)	Mandiri	Sudah tersertifikasi, minimal 10 kasus per tahun
Punksi pleura	Mandiri	Bila efusi masif dan sadar
Ekokardiografi dasar	Dengan supervisi langsung	Sampai kompetensi dinyatakan lengkap oleh KSM

Tindakan endoskopi diagnostik	Dengan supervisi tidak langsung	Harus ada surat penugasan klinis dari Komite Medik

Untuk **Sub-spesialis Kardiologi Intervensi**:

Tindakan Klinis	Level	Syarat/Ketentuan
Kateterisasi jantung diagnostik	Mandiri	Minimal 50 kasus per tahun, tersertifikasi
PCI (Percutaneous Coronary Intervention)	Mandiri	Minimal 75 kasus per tahun, dengan laporan outcome
TAVI/TAVR	Dengan supervisi langsung	Prosedur baru di RS, butuh proctor eksternal
Bedah katup minimal invasif	Tidak diberikan	Kewenangan bedah toraks kardiovaskular, bukan subspesialis kardiologi

Tips: Jangan buat RKK terlalu umum (“boleh lakukan semua tindakan sesuai kompetensi”). Surveyor akan menilai tidak ada bukti verifikasi. Buat daftar spesifik per jenis tindakan, meskipun untuk dokter umum. Minimal 10-15 tindakan inti per spesialisasi.

✅ **Checklist: Pastikan setiap tindakan di RKK memiliki dokumen pendukung: sertifikat pelatihan, log book, surat penugasan klinis, atau hasil evaluasi proctorship. Satu tindakan tanpa bukti = poin temuan saat akreditasi.**

Langkah 3: Verifikasi white paper kompetensi

Untuk tindakan yang berisiko tinggi atau baru, susun **white paper kompetensi** terpisah. Isinya: definisi tindakan, indikasi, kontraindikasi, prasyarat dokter, jumlah minimal kasus, metode evaluasi, dan jangka waktu evaluasi. Contoh: dokter spesialis obgyn yang ingin kewenangan laparoskopi, buat white paper yang menyebutkan minimal 20 kasus dengan supervisi, lalu dievaluasi oleh tim proctorship RS.

Langkah 4: Tetapkan masa berlaku dan siklus review

Sesuai Permenkes 6/2026, RKK berlaku maksimal 3 tahun. Cantumkan tanggal mulai, tanggal berakhir, dan jadwal evaluasi berkala (tahunan atau saat rekredensial). Jangan lupa tautkan dengan sistem pengingat rekredensial 3 tahunan.

INTI BAB: Susun RKK per spesialisasi dengan level kewenangan yang jelas, daftar tindakan spesifik, dan bukti pendukung untuk setiap kewenangan. Satu RKK yang rapi akan menjadi fondasi rekredensial dan bukti telusur akreditasi yang kuat.

BAB 4

Menulis White Paper Kompetensi Klinis

White paper kompetensi klinis adalah dokumen naratif yang memetakan kompetensi aktual seorang staf medis ke daftar kewenangan klinis yang diusulkan. Permenkes 6/2026 mensyaratkan setiap pengajuan kewenangan klinis baru atau perpanjangan harus didukung white paper ini. Format lama yang hanya berisi riwayat pendidikan tidak lagi cukup—sekarang harus jelas hubungan antara kompetensi (dari pelatihan, pengalaman, sertifikasi) dengan kewenangan spesifik yang diminta.

Sebelum mulai menulis, pahami dulu komponen wajib white paper agar tidak ada yang terlewat saat surveyor akreditasi memeriksa.

> ✅ **Checklist: Identitas staf medis & nomor STR, ringkasan pendidikan/pelatihan/pengalaman, daftar kompetensi inti, daftar kewenangan klinis yang diusulkan lengkap dengan level, justifikasi/evidence per kewenangan, rekomendasi peer group/kepala departemen, tanda tangan & tanggal.**

Langkah menyusun white paper kompetensi klinis:

1. **Kumpulkan evidence kompetensi.** Mulai dari ijazah, STR, sertifikat pelatihan/workshop, log book prosedur, surat keterangan praktik sebelumnya, hingga bukti CME/CPD. Simpan dalam folder digital per dokter agar mudah ditelusur.
2. **Tentukan daftar kewenangan klinis yang diminta.** Gunakan template

RKK per spesialisasi sebagai acuan. Pastikan tiap butir kewenangan spesifik dan terukur, misalnya “melakukan endoskopi saluran cerna atas diagnostik” bukan sekadar “menangani kasus pencernaan”.

3. **Petakan kompetensi ke kewenangan.** Buat tabel sederhana: kolom Kompetensi, Bukti, Kewenangan yang Diusulkan, Level. Ini inti dari white paper—pemetaan yang menunjukkan bahwa setiap kewenangan didukung kompetensi nyata.

Contoh pemetaan untuk dokter spesialis penyakit dalam:

Kompetensi	Bukti	Kewenangan yang Diusulkan	Level
Mampu melakukan endoskopi saluran cerna atas diagnostik	Sertifikat pelatihan endoskopi 2022, log book 40 kasus mandiri	Melakukan endoskopi saluran cerna atas diagnostik	Mandiri
Mampu melakukan ekokardiografi transtorakal dasar	Workshop echo 2023, 25 kasus dengan supervisi	Melakukan ekokardiografi transtorakal dasar	Dengan supervisi

4. **Tulis justifikasi singkat untuk setiap kewenangan.** Jelaskan mengapa kompetensi tersebut mendukung kewenangan klinis dan mengapa aman diberikan. Gunakan bahasa klinis ringkas, misalnya: “Kompetensi endoskopi diperoleh melalui pelatihan terstruktur 2022 dan log book 40

kasus mandiri dengan komplikasi minimal, sehingga aman diberikan kewenangan mandiri."

5. **Reviu oleh peer group atau Komite Medik.** Pastikan tidak ada kewenangan yang tidak didukung bukti kuat. Jika ada keraguan, minta bukti tambahan atau turunkan level kewenangan dari mandiri menjadi supervisi.
6. **Finalisasi dan tanda tangan.** Simpan white paper ini sebagai bagian berkas kredensial, siap ditunjukkan saat surveyor akreditasi datang. Jangan lupa mencantumkan tanggal dan tanda tangan pihak yang berwenang.

> 💡 **Tips: Gunakan template white paper yang sudah distandarkan Komite Medik agar semua dokter mengisi dengan format sama. Ini akan sangat menghemat waktu saat rekredensial 3 tahunan tiba—Anda tinggal memperbarui bukti, bukan menyusun dari nol.**

Dengan white paper yang terstruktur, Komite Medik punya bukti tertulis bahwa setiap kewenangan klinis sudah diverifikasi secara individu, bukan sekadar daftar nama di atas kertas.

INTI BAB: White paper kompetensi klinis harus memetakan secara eksplisit antara kompetensi (dengan bukti) dan kewenangan klinis yang diusulkan, ditulis dalam format standar agar valid dan siap telusur saat akreditasi.

B A B 5

Form Evaluasi Kinerja Klinis Berkala

Kalau kamu pernah dengar komplain dari surveyor akreditasi soal “form evaluasi kinerja klinis tidak konsisten antar periode”, itu bukan karena mereka rewel. Itu karena data yang tidak seragam membuat rekam jejak kompetensi dokter tidak bisa ditelusur. Padahal, Permenkes 6/2026 menuntut bukti bahwa setiap staf medis dievaluasi secara berkala dengan instrumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah paling umum: tiap periode, tim kredensial memakai format berbeda—ada yang cuma selembar narasi bebas, ada yang pakai checklist minim indikator, ada yang malah tidak ada form sama sekali dan hanya mengandalkan rapat lisan. Akibatnya, ketika rekredensial 3 tahunan tiba, Komite Medik harus menyusun ulang dari nol, dan bukti penilaian periode sebelumnya sulit dibandingkan.

Solusinya sederhana tapi krusial: **satu template evaluasi kinerja klinis yang baku, dipakai berulang setiap periode, dan mudah diisi oleh siapa pun yang ditugaskan menilai.** Template ini bukan untuk mempersulit, justru untuk memangkas waktu karena semua orang sudah tahu persis apa yang harus diisi.

Langkah Menyusun Form Evaluasi Kinerja Klinis Berkala

Ikuti lima langkah praktik ini untuk membangun form yang siap pakai, bukan cuma dokumen formalitas.

1. Tetapkan 5 komponen penilaian inti

Form yang baik tidak perlu panjang, tapi harus mengukur hal yang benar. Lima komponen berikut sudah mencakup aspek klinis dan profesional sesuai standar akreditasi:

Checklist komponen wajib form evaluasi:

- **Kompetensi klinis** — kesesuaian tindakan dengan RKK dan white paper yang berlaku.
- **Keselamatan pasien** — keterlibatan dalam pelaporan insiden, kepatuhan surgical safety checklist, dan tindakan pencegahan risiko.
- **Komunikasi & kolaborasi** — interaksi dengan pasien, keluarga, perawat, dan sejawat.
- **Etika & disiplin** — kehadiran, kepatuhan pada SOP, sikap profesional.
- **Kepatuhan pada kewenangan klinis** — tidak melakukan tindakan di luar RKK tanpa proses kredensial tambahan.

Setiap komponen diberi skala penilaian yang jelas, misalnya 1–5 (1 = Sangat Kurang, 5 = Sangat Baik) atau kategori “Memenuhi / Tidak Memenuhi” dengan kolom catatan. Hindari skala ambigu seperti “cukup” tanpa definisi.

2. Sertakan kolom bukti pendukung dan sumber data

Jangan biarkan penilai mengisi berdasarkan kesan pribadi. Setiap komponen harus didukung data objektif. Buat kolom kecil untuk menuliskan sumber bukti, misalnya: “observasi langsung di ruang operasi”, “audit rekam medis bulan Januari”, “laporan insiden keselamatan pasien”, atau “umpan balik dari kepala ruangan”.

Ini menjawab kebutuhan Direksi RS tentang bukti tertulis bahwa kewenangan klinis sudah diverifikasi, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas.

3. Buat panduan pengisian singkat dalam satu halaman

Sering kali form bagus tapi hasilnya tidak konsisten karena penilai tidak punya acuan. Lampirkan instruksi ringkas: bagaimana memberi skor, kapan harus menulis catatan naratif, dan apa yang dimaksud “bukti pendukung”. Panduan ini cukup satu halaman, tidak perlu buku.

4. Tambahkan area naratif untuk umpan balik kualitatif

Skor angka saja tidak cukup untuk menggambarkan konteks. Sediakan ruang untuk menulis contoh konkret, misalnya: “Dokter A berhasil menangani 12 kasus bedah digestif tanpa komplikasi”, atau “Perlu penguatan komunikasi dengan keluarga pasien saat menjelaskan risiko tindakan”.

Narasi ini sangat berguna saat rekredensial atau saat ada pertanyaan dari surveyor.

5. Simpan dan gunakan template yang sama setiap periode

Setelah template final disetujui Komite Medik, simpan dalam format digital yang mudah diakses tim kredensial. Jangan ubah strukturnya setiap tahun. Yang berubah hanya tanggal penilaian, nama dokter, dan isi penilaian. Konsistensi format inilah yang membuat tren kinerja dokter bisa dibandingkan antar periode.

> **Tips anti-subjektivitas: Latih minimal dua penilai per dokter (misalnya Ketua SMF dan satu peer sejawat). Bandingkan skor keduanya; jika selisih lebih dari 2 poin pada skala 1–5, wajib ada diskusi klarifikasi sebelum form final ditandatangani. Ini menjaga validitas dan mengurangi bias personal.**

Contoh Pengisian Praktis

Misalnya untuk dr. Budi, Sp.PD, periode Januari–Desember 2026:

Komponen	Skor (1–5)	Bukti Pendukung	Catatan Naratif
Kompetensi klinis	4	Audit 20 rekam medis kasus diabetes melitus, kesesuaian terapi 85%	Perlu pendalaman tata laksana komplikasi ginjal diabetik
Keselamatan pasien	5	Tidak ada insiden, ikut serta pelaporan 2 near-miss	Aktif dalam program keselamatan
Komunikasi & kolaborasi	4	Umpan balik perawat: baik, kadang kurang melibatkan keluarga	Sudah lebih baik dari periode lalu
Etika & disiplin	5	Kehadiran 100%, tidak ada teguran	Disiplin dan tepat waktu
Kepatuhan RKK	4	Tidak ada tindakan di luar RKK, 1 permohonan penambahan kewenangan diajukan tepat prosedur	Proses kredensial tambahan berjalan

Dengan format seperti ini, tim kredensial bisa menyelesaikan evaluasi tahunan lebih cepat, dan data antar periode langsung terlihat jelas. Saat surveyor akreditasi datang, kamu tinggal menunjukkan form yang seragam dan lengkap—bukan setumpuk kertas dengan format acak yang membuat mereka mengernyit.

Ingat: form evaluasi bukan sekadar syarat administratif. Ini alat untuk memastikan pasien ditangani oleh tenaga medis yang kompetensinya terus

terpantau.

INTI BAB: Buat satu template evaluasi kinerja klinis berkala dengan lima komponen inti, skala penilaian jelas, bukti pendukung, dan panduan pengisian singkat. Gunakan template yang sama setiap periode agar penilaian konsisten, valid, dan siap telusur saat akreditasi.

B A B 6

Mekanisme Rapat dan Keputusan Komite Kredensial

Rapat kredensial sering dianggap selesai begitu semua setuju. Padahal, di mata surveyor akreditasi, yang diuji bukan suasana rapatnya, melainkan jejak tertulisnya. Notulen yang asal jadi bisa menggugurkan seluruh keputusan pemberian kewenangan klinis—walaupun secara lisan rapatnya berjalan lancar.

Bayangkan Anda harus membuktikan bahwa dr. X layak melakukan tindakan bedah digestif. Jika dokumen rapat tidak memuat siapa yang hadir, apa yang diputuskan, dan dasar pertimbangannya, maka kewenangan klinis dr. X dianggap tidak sah. Jadi, kuncinya adalah mendokumentasikan proses rapat secara disiplin, bukan sekadar membuat catatan singkat.

Berikut langkah praktis agar dokumentasi rapat Anda sah secara administratif dan siap diaudit kapan pun.

Langkah 1: Pastikan kuorum dan kehadiran tercatat eksplisit

Sebelum rapat dimulai, sekretaris harus mencatat siapa saja yang hadir, baik fisik maupun daring. Jangan tulis “hadir 7 orang” tanpa nama. Tulis nama lengkap, jabatan di komite, dan perannya dalam pengambilan keputusan. Jika rapat kredensial dokter spesialis, pastikan ada perwakilan dari bidang terkait.

Contoh baris kehadiran yang baik:

> Hadir: dr. A (Ketua Komite Kredensial), dr. B (Sekretaris), dr. C (Anggota mewakili Bedah), dr. D (Anggota mewakili Penyakit Dalam), dr. E (Perwakilan Manajemen). Kuorum terpenuhi: 5 dari 7

anggota.

Langkah 2: Gunakan template notulen berunsur legal

Jangan membuat notulen di kertas kosong. Buat template yang memuat kop resmi rumah sakit, nomor dokumen, tanggal rapat, agenda, dan daftar hadir. Ini memudahkan audit telusur. Template yang sama dipakai untuk semua rapat kredensial, sehingga konsisten.

> ⚠ **Penting: Notulen rapat kredensial harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan Sekretaris, bukan hanya distempel atau diparaf asisten. Tanda tangan ini menegaskan bahwa keputusan memang diambil secara resmi.**

Langkah 3: Tulis keputusan dengan format “memutuskan” yang spesifik

Hindari kalimat samar seperti “disetujui”. Tuliskan secara eksplisit: “Komite Kredensial memutuskan memberikan kewenangan klinis kepada dr. X untuk tindakan appendektomi terbuka dan laparoskopi, dengan masa berlaku 3 tahun, berdasarkan evaluasi kompetensi dan rekomendasi Kepala SMF Bedah.” Cantumkan juga jika ada pembatasan atau persyaratan khusus.

Untuk setiap dokter yang dibahas, buat paragraf terpisah. Ini penting karena saat rekredensial 3 tahunan, auditor akan menelusuri apakah keputusan hari ini sesuai dengan bukti yang ada.

Langkah 4: Lampirkan bukti pendukung di menit yang sama

Setiap keputusan harus bisa ditelusuri ke dokumen sumber. Di akhir notulen, buat daftar lampiran: RKK, white paper kompetensi, form evaluasi kinerja,

sertifikat pelatihan, dan surat rekomendasi. Simpan lampiran dalam satu folder digital atau fisik yang sama dengan notulen. Jangan terpisah karena bisa hilang saat audit.

Langkah 5: Arsipkan dengan sistem penomoran dan pengingat

Beri nomor unik pada setiap notulen, misalnya: `NOT-KRED/VI/2026/001`. Lalu masukkan ke kalender pengingat untuk rapat berikutnya atau jadwal rekredensial. Dengan begitu, tidak ada rapat yang terlewat dan setiap dokter punya riwayat keputusan yang runtut.

> ✅ **Checklist: Sebelum rapat ditutup, pastikan: (1) daftar hadir lengkap dengan nama dan jabatan, (2) kuorum tercatat, (3) setiap keputusan ditulis spesifik dengan nama dokter dan tindakan, (4) lampiran bukti sudah disebut, (5) notulen ditandatangani dua pejabat komite.**

Dengan mengikuti lima langkah di atas, dokumen rapat kredensial Anda tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga menjadi alat bukti kuat saat surveyor akreditasi memeriksa rekam jejak kewenangan klinis seluruh staf medis.

INTI BAB: Dokumentasi rapat Komite Kredensial harus memuat kehadiran, kuorum, keputusan spesifik per dokter, lampiran bukti, dan tanda tangan pejabat berwenang agar sah secara administratif dan mudah diaudit.

B A B 7

Siklus Rekredensial 3 Tahunan Tanpa Terlambat

Rekredensial tiga tahunan sering jadi siklus yang bikin panik: mendadak rapat maraton, dokumen dikejar-kejar, dan ada saja staf medis yang terlewat jatuh tempo. Padahal, Permenkes 6/2026 menuntut proses ini berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan bisa ditelusur kapan pun. Kuncinya bukan kerja lebih keras di menit-menit akhir, melainkan membangun sistem pengingat dan checklist yang membuat siklus berjalan nyaris otomatis.

Bayangkan siklus rekredensial seperti jadwal perawatan kendaraan. Kalau tidak ada pengingat servis, mobil tetap dipakai sampai mogok di jalan. Begitu juga kewenangan klinis staf medis—kalau tidak ada sistem yang menandai jatuh tempo, RKK lama, white paper usang, dan evaluasi kinerja yang tidak konsisten akan menumpuk menjadi temuan akreditasi.

Langkah 1: Bangun database induk staf medis dengan tanggal jatuh tempo

Buat satu file utama (bisa spreadsheet atau aplikasi sederhana) yang memuat: nama dokter, spesialisasi, RKK aktif, tanggal mulai berlaku, tanggal jatuh tempo rekredensial berikutnya, dan status dokumen pendukung. Format ini harus bisa difilter berdasarkan bulan jatuh tempo. Kalau memungkinkan, gunakan formula warna—misalnya kuning untuk jatuh tempo 6 bulan lagi, merah untuk 2 bulan lagi. Database ini jadi sumber kebenaran tunggal, bukan catatan terpisah di masing-masing anggota Komite Medik.

Langkah 2: Tetapkan timeline mundur 6 bulan sebelum jatuh tempo

Jangan menunggu H-1 bulan. Buat jadwal baku untuk setiap staf yang akan

memasuki siklus rekredensial:

- **H-6 bulan:** Kirim pemberitahuan resmi kepada staf medis terkait, lengkap dengan daftar dokumen yang harus disiapkan (RKK usulan, log praktik klinis, bukti CME, surat pernyataan tidak sedang dalam sanksi).
- **H-4 bulan:** Verifikasi kelengkapan white paper kompetensi. Jika ada kompetensi baru atau perlu white paper tambahan, serahkan ke Subkomite Kredensial untuk disusun.
- **H-2 bulan:** Lakukan evaluasi kinerja klinis berkala menggunakan form standar. Pastikan form yang dipakai sama untuk semua periode, sehingga tidak ada inkonsistensi yang dipertanyakan surveyor.
- **H-1 bulan:** Rapat Komite Medik untuk membahas rekomendasi kewenangan klinis. Keputusan dicatat dalam risalah resmi.
- **H-14 hari:** Terbitkan RKK baru atau perpanjangan, tanda tangani oleh Ketua Komite Medik dan Direktur RS.
- **H-0:** Arsipkan seluruh dokumen dalam satu folder per staf medis, siap telusur.

> ✅ **Checklist: Apakah Anda sudah punya database induk berisi tanggal jatuh tempo tiap staf medis? Apakah timeline mundur sudah disepakati oleh Komite Medik? Apakah form evaluasi kinerja klinis konsisten antar periode? Apakah ada folder bukti telusur per dokter yang terus diperbarui?**

Langkah 3: Jadwalkan rapat Komite Medik secara berkala, bukan insidental

Banyak RS baru menggelar rapat rekredensial saat ada staf yang hampir jatuh

tempo. Akibatnya, jadwal bentrok dan keputusan terburu-buru. Solusinya: tetapkan rapat Subkomite Kredensial sebulan sekali, dan rapat pleno Komite Medik untuk penetapan kewenangan klinis minimal triwulanan. Dengan begitu, setiap berkas yang masuk H-1 bulan sudah menunggu agenda rapat yang pasti.

Langkah 4: Gunakan pengingat otomatis di kalender digital

Manfaatkan Google Calendar, Outlook, atau aplikasi manajemen tugas. Buat pengingat berulang untuk setiap tahap timeline di atas. Misalnya, setiap tanggal 1, sistem mengingatkan anggota Subkomite Kredensial untuk mengecek database staf yang memasuki H-6 bulan. Setiap tanggal 15, pengingat untuk memverifikasi white paper yang masuk H-4 bulan. Prinsipnya: jangan mengandalkan ingatan manusia. Sistem yang mengingatkan.

Langkah 5: Lakukan audit dokumen satu kali setahun

Setahun sekali, luangkan waktu 2–3 jam untuk mengaudit kelengkapan folder rekredensial seluruh staf medis. Cek: apakah RKK yang berlaku masih sesuai struktur Permenkes 6/2026? Apakah white paper kompetensi terbaru sudah tersimpan? Apakah evaluasi kinerja klinis terakhir belum lebih dari 1 tahun? Audit kecil ini mencegah temuan besar saat survei akreditasi.

⛔ **Waspada: Jangan pernah menganggap remeh keterlambatan satu bulan. Dalam rekredensial, keterlambatan satu bulan bisa berarti kewenangan klinis seorang dokter tidak sah secara administratif, dan jika terjadi insiden medis, RS bisa terpapar risiko hukum yang serius.**

Dengan sistem pengingat dan checklist yang berjalan konsisten, siklus rekredensial tiga tahunan bukan lagi beban mendadak, melainkan ritme kerja yang terprediksi. Komite Medik tinggal mengeksekusi, bukan lagi memadamkan kebakaran.

INTI BAB: Bangun database induk tanggal jatuh tempo rekredensial setiap staf medis, jalankan timeline mundur 6 bulan dengan checklist dokumen yang baku, dan otomatiskan pengingatnya agar tidak ada kewenangan klinis yang kedaluwarsa atau terlewat.

B A B 8

Menyiapkan Bukti Telusur untuk Surveyor Akreditasi

Saat surveyor akreditasi masuk ke ruang Komite Medik, yang mereka cari bukan sekadar tumpukan map tebal. Mereka ingin melihat **alur logis** dari kompetensi seorang dokter sampai kewenangan klinis yang diberikan. Kalau dokumen berserakan, format tidak konsisten, atau ada data yang tidak nyambung, pertanyaan surveyor akan makin tajam dan waktu visit makin lama. Jadi, kunci di bab ini bukan “punya banyak dokumen”, tapi **menyusun bukti telusur yang rapi dan runut** agar dalam 10–15 menit surveyor bisa menemukan semua yang mereka butuhkan.

Berikut langkah praktis menyiapkan bukti telusur yang siap ditunjukkan.

Langkah 1: Buat peta dokumen per staf medis

Jangan menunggu surveyor datang baru mencari berkas. Mulai sekarang, buat daftar semua staf medis yang sedang aktif praktik, lalu petakan dokumen apa saja yang harus ada untuk setiap orang. Minimal ada lima dokumen inti:

- **RKK (Rincian Kewenangan Klinis)** format baru sesuai Permenkes 6/2026 — bukan sekadar daftar tindakan, tetapi memuat level kewenangan, prasyarat kompetensi, dan masa berlaku.
- **White paper kompetensi** untuk kewenangan klinis tertentu yang mensyaratkan pembuktian lebih detail (misalnya tindakan invasif atau subspesialis).
- **Form evaluasi kinerja klinis** periode terakhir — isi harus konsisten, ada tanggal, nama penilai, dan kesimpulan jelas.

- **Bukti proses kredensial & rekredensial** — berita acara rapat komite, rekomendasi, dan keputusan pemberian kewenangan klinis.
- **Bukti verifikasi kompetensi** (sertifikat pelatihan, log book, surat keterapan) yang mendukung setiap kewenangan yang tercantum di RKK.

> ✅ **Checklist: Untuk setiap dokter, pastikan 5 dokumen ini tersedia: (1) RKK terbaru, (2) white paper kompetensi bila disyaratkan, (3) evaluasi kinerja klinis periode aktif, (4) SK kewenangan klinis yang masih berlaku, (5) bukti rekredensial terakhir tidak melewati 3 tahun.**

Langkah 2: Susun dokumen mengikuti alur “kompetensi → kewenangan”

Surveyor biasanya menelusuri satu nama dokter secara acak. Mereka akan bertanya: “Dokter X dapat kewenangan pasang CVC, dasarnya apa?” Nah, bukti telusur Anda harus bisa menjawab itu dalam hitungan detik.

Susun per dokter dengan urutan seperti ini:

1. **Ringkasan profil dokter** — satu halaman berisi nama, spesialisasi, nomor STR, tanggal mulai praktik, dan status keanggotaan staf medis.
2. **RKK yang sudah disetujui** — tandai kewenangan yang sedang aktif, dan coret yang sudah dicabut dengan catatan tanggal.
3. **White paper** untuk kewenangan yang butuh justifikasi ekstra — letakkan tepat setelah RKK agar mudah dirujuk.
4. **Evaluasi kinerja klinis** 1–2 periode terakhir — tunjukkan tren, bukan hanya satu nilai akhir.

5. **Bukti pendukung** — sertifikat, log book, atau surat keterangan yang relevan dengan kewenangan di RKK.

Dengan urutan ini, saat surveyor minta “tunjukkan white paper untuk dokter bedah digestif”, Anda langsung bisa mengambil dari map yang sama tanpa perlu mencari di tumpukan lain.

> 💡 **Tips: Gunakan tab pembatas atau folder digital dengan nama file yang konsisten: `NamaDokter_RKK_2026.pdf`, `NamaDokter_WhitePaper_Appendiktomi.pdf`, `NamaDokter_EvaluasiKinerja_2025.pdf`. Konsistensi penamaan akan sangat membantu saat surveyor meminta bukti tambahan secara mendadak.**

Langkah 3: Siapkan “cerita” singkat di balik setiap dokumen

Surveyor tidak hanya membaca dokumen, mereka akan mewawancarai Komite Medik atau staf kredensial. Jadi, jangan hanya menyerahkan map, tapi siapkan narasi singkatnya: “Dokter ini mengajukan kewenangan bedah digestif tingkat mandiri, white paper-nya memuat bukti 25 kasus sebagai operator utama, evaluasi kinerja 3 periode terakhir kategori baik, dan rekredensial terakhir dilakukan Januari 2025.”

Cerita ini bukan untuk menghafal semua data, tapi untuk menunjukkan bahwa Komite Medik paham isi dokumen mereka sendiri. Kalau yang menyerahkan dokumen terlihat ragu atau tidak tahu letak berkas, surveyor akan menandai sebagai temuan.

⚠ **Penting: Jangan pernah menyerahkan dokumen yang tidak Anda pahami isinya. Jika ada RKK atau white paper yang masih template kosong, lebih baik akui sedang dalam proses revisi dan tunjukkan rencana kerjanya, daripada menyerahkan dokumen asal jadi yang bisa memicu temuan lebih besar.**

Langkah 4: Uji sendiri sebelum surveyor datang

Lakukan simulasi telusur internal. Minta satu orang berperan sebagai surveyor, pilih 2–3 nama dokter secara acak, dan minta tim kredensial menunjukkan kelengkapan dokumen dalam waktu 5 menit per nama. Catat di mana proses tersendat, apakah karena file tidak ketemu, format tidak konsisten, atau justifikasi kewenangan kurang kuat. Perbaiki sebelum visit resmi.

Dengan empat langkah di atas, bukti telusur Anda bukan lagi sekadar kumpulan kertas, melainkan sistem dokumentasi yang mencerminkan tata kelola klinis yang solid.

INTI BAB: Bukti telusur akreditasi harus disusun per dokter mengikuti alur logis kompetensi → kewenangan, dengan format konsisten dan siap dijelaskan oleh tim kredensial.

B A B 9

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Banyak dokumen kredensial ditolak surveyor bukan karena kurang lengkap, tetapi karena isinya masih memakai pola lama yang tidak bisa ditelusur. Surveyor akreditasi tidak hanya memeriksa ada atau tidaknya dokumen, melainkan menilai apakah dokumen itu membuktikan kewenangan klinis setiap staf medis secara spesifik, terukur, dan konsisten. Berikut kesalahan paling sering dan cara memperbaikinya.

1. **RKK masih format lama.** Format lama umumnya hanya mencantumkan judul kompetensi tanpa rincian tindakan, level kewenangan, dan syarat. Surveyor melihat ini sebagai dokumen yang tidak implementatif. Perbaiki dengan menyusun ulang RKK per spesialisasi: setiap kompetensi dipecah menjadi daftar tindakan klinis yang boleh dilakukan, dengan tanda level mandiri atau perlu supervisi, serta syarat kompetensi pendukung seperti sertifikat atau logbook. Langkah cepat: petakan dari standar profesi masing-masing spesialisasi, masukkan ke template yang sudah disesuaikan struktur Permenkes 6/2026, lalu validasi oleh ketua KSM sebelum ditandatangani.
2. **White paper kompetensi seperti CV, bukan bukti ilmiah.** Banyak white paper hanya menyalin riwayat hidup dokter, tanpa menjelaskan dasar keilmuan, indikasi, prosedur, risiko, dan bukti pelatihan. Akibatnya surveyor tidak melihat justifikasi mengapa dokter tersebut diberi kewenangan. Perbaiki: untuk setiap kompetensi yang dimasukkan ke RKK, buat white paper singkat (2–4 halaman) yang memuat definisi kompetensi, lingkup tindakan, syarat pelatihan minimal, bukti

kasus/logbook, dan proses supervisi. Lampirkan sertifikat pelatihan atau logbook sebagai bukti telusur.

3. **Evaluasi kinerja klinis tidak konsisten antar periode.** Form yang berubah-ubah atau indikator yang tidak terukur membuat surveyor mempertanyakan validitas penilaian. Perbaiki dengan membuat satu form standar evaluasi kinerja klinis yang dipakai terus-menerus. Tentukan minimal 5–7 indikator kuantitatif per spesialisasi, misalnya angka komplikasi tindakan, kepatuhan protokol klinis, ketepatan diagnosis, jumlah tindakan sesuai kewenangan, dan umpan balik pasien. Isi secara berkala (minimal 6 bulan sekali) dan review oleh komite medik. Simpan hasil evaluasi dalam arsip digital per dokter.
4. **Rekredensial 3 tahunan terlambat.** Tidak adanya sistem pengingat membuat banyak staf medis melewati tanggal jatuh tempo, sehingga kewenangan klinisnya tidak sah secara administratif. Perbaiki dengan membuat kalender kredensial: catat tanggal mulai berlaku RKK setiap dokter, set pengingat 6 bulan sebelum jatuh tempo, dan siapkan checklist dokumen rekredensial (RKK baru, white paper, evaluasi kinerja terbaru, sertifikat pelatihan). Tunjuk satu petugas admin untuk memantau kalender ini dan melaporkan statusnya ke komite medik setiap bulan.
5. **Bukti verifikasi hanya daftar nama di atas kertas.** Surveyor butuh bukti bahwa setiap dokter benar-benar diverifikasi kewenangannya, bukan sekadar surat penugasan. Perbaiki dengan membuat berita acara verifikasi per dokter yang memuat nama, spesialisasi, kompetensi yang diverifikasi, hasil verifikasi, dan tanda tangan komite medik beserta direksi. Simpan berita acara ini bersama RKK yang telah disetujui sebagai satu paket arsip digital per dokter.

⛔ **Waspada: Jangan pernah menyerahkan dokumen RKK yang hanya berisi daftar nama tindakan tanpa level kewenangan dan syarat kompetensi. Surveyor langsung menandai ini sebagai tidak sesuai Permenkes 6/2026, dan proses akreditasi bisa terhambat karenanya.**

Karena tenggat implementasi yang mepet, banyak rumah sakit tergoda mengisi template secara asal tanpa validasi. Ini justru menciptakan masalah baru saat surveyor melakukan telusur. Solusinya bukan kerja lebih cepat tanpa arah, tetapi menyusun SOP sederhana alur kredensial: siapa yang menyusun RKK, siapa yang mereview white paper, siapa yang memvalidasi evaluasi kinerja, dan kapan rekredensial dijalankan. Dengan SOP yang jelas, setiap dokumen yang dihasilkan akan konsisten dan mudah dipertanggungjawabkan.

::: {.callout .checklist} **Checklist:** Sebelum dokumen diserahkan, pastikan: (1) setiap RKK memuat rincian tindakan per kompetensi dengan level kewenangan, (2) white paper mencantumkan bukti pelatihan dan logbook, (3) evaluasi kinerja memakai indikator terukur yang sama antar